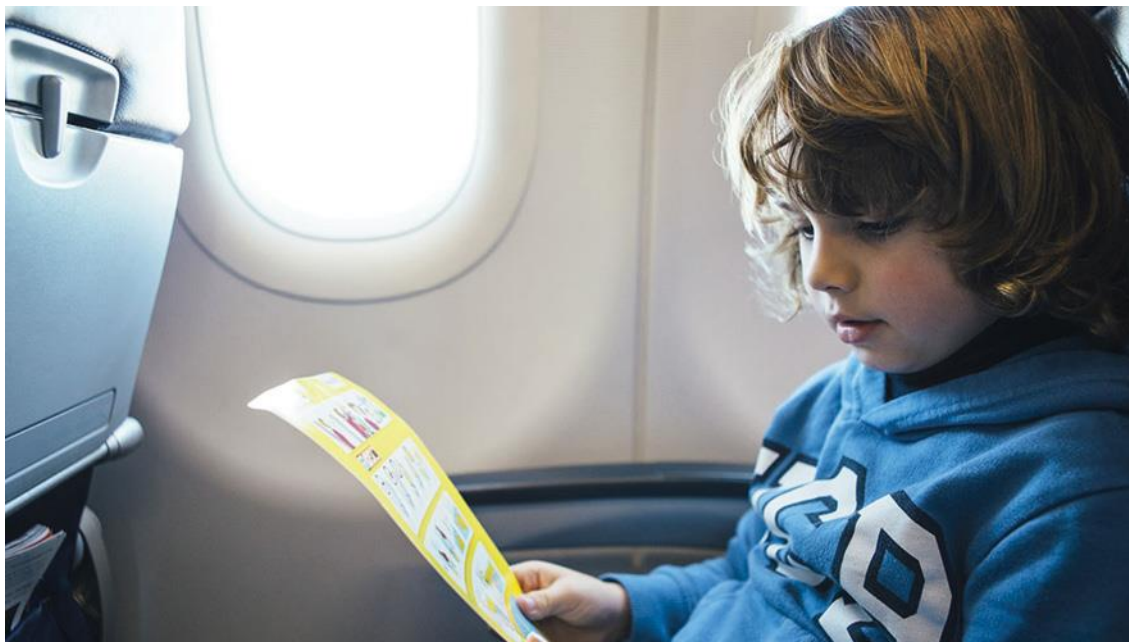


Master Patología del lenguaje y del habla**Módulo 16: Alteraciones del lenguaje escrito****Unidad didáctica 05: La dislexia****Definición de la dislexia**

Dislexia fue el primer término general usado para designar varios problemas de aprendizaje. Con el tiempo, estos fueron subdivididos y clasificados para definir problemas diferentes. Por eso, se puede llamar a la dislexia como la matriz de los problemas de aprendizaje. Hasta la fecha, se usan al menos 70 nombres para describir sus variantes.

Inicialmente, los investigadores pensaban que los disléxicos tenían algún daño cerebral o neuronal, o quizá una función defectuosa congénita que interfiere en los procesos mentales necesarios para leer.

**DEFINICIÓN****La dislexia**

Es un trastorno específico del aprendizaje que se presenta en personas sin discapacidad intelectual; visión, audición y lenguaje normales para su edad; enseñanza y estimulación adecuada y no presentan ningún daño neurológico ni enfermedad mental que lo pueda justificar.

Está considerada como consecuencia de retrasos madurativos que afectarían al establecimiento de las relaciones espaciotemporales, a los dominios motrices, la capacidad de discriminación perceptiva visual, a los procesos simbólicos, a la capacidad atencional y numérica o a la competencia social y personal, en sujetos con un desarrollo global acorde con su edad cronológica, con unas aptitudes intelectuales asociadas con el funcionamiento lingüístico (vocabulario, razonamiento verbal y comprensión verbal, normales altas), y en un medio

socioeconómico y cultural no determinado. La mayoría de los autores están de acuerdo en distinguir entre:

Dislexia Adquirida o Alexia

Como resultado de una lesión, traumatismo. Es decir, de la pérdida de la comprensión del lenguaje escrito (lectura) que ya se había adquirido previamente.

Dislexia Evolutiva

Desorden o dificultad que surge a la hora de escribir o leer, a pesar de haber tenido una enseñanza correcta, un nivel mental normal y un entorno sociocultural normal.

Etimológicamente, la palabra dislexia se refiere a dificultades en el lenguaje; la acepción actual alude a problemas de lectura: es un trastorno de adquisición de la lectura. Este trastorno dificulta la integración con sentido de los símbolos lingüísticos y perceptivos, a pesar de que en los últimos años este concepto se emplea, con una mayor precisión, para designar un síndrome determinado, cómo explicaremos más adelante, que se manifiesta como una dificultad para la distinción y memorización de letras o grupos de letras, falta de orden y ritmo en la colocación y mala estructuración de las frases, afectando tanto a la lectura como a la escritura.

Las principales habilidades que estos niños no dominan son: el lenguaje receptivo, el lenguaje escrito y el lenguaje expresivo (el paso de la codificación visual a la verbal, memoria a corto plazo, percepción de orden y secuenciación). En el trastorno disléxico, muy a menudo, se añaden otros problemas de aprendizaje escolar como, por ejemplo: disgrafía, disortografía, dificultades en la pronunciación. Si bien todos los principios que vienen a continuación son discutibles hoy en día, los exponemos brevemente para evidenciar la evolución histórica del concepto de dislexia:

Para Ronald D. Davis (1994), disléxico, investigador y maestro, la dislexia sería un estilo único de aprendizaje, un don, un talento y no una inhabilidad para el aprendizaje de la lectoescritura. La dislexia es el resultado de un talento en la percepción, pero en algunas situaciones ese talento se convierte en desventajas, como veremos más adelante. Por el contrario, algunas de las habilidades básicas que son comunes a todos los disléxicos serían las siguientes:

01 Pueden usar su don mental para alterar o crear percepciones.

Son altamente conscientes de su entorno

02

03 Son más curiosos que el promedio de la gente.

Piensan más con imágenes que con palabras.

04

05 Son altamente intuitivos y perspicaces.

Piensen y perciben multidimensionalmente (usando todos los sentidos).

06

07 Pueden experimentar el pensamiento como realidad.

Tienen una gran imaginación.

08

Ronald considera también la dislexia como el producto del pensamiento; sería una forma especial de reaccionar ante el sentimiento de confusión. Mientras que Quirós define la dislexia como una afección caracterizada fundamentalmente por las dificultades de aprendizaje en la lectura que no obedecen a deficiencias fonarticularias, sensoriales, psíquicas o intelectuales demostrables.

Según el autor, la dislexia se presenta, con mucha frecuencia, acompañada de otros trastornos en el aprendizaje de la escritura y normalmente, estos trastornos de la escritura se engloban dentro del nombrado síndrome.

La dislexia (dislexia específica de evolución) debería entenderse como una consecuencia de cualquier causa neurológica, psíquica o educativa que perturbe la adquisición del lenguaje escrito (lectura). Consideran los términos de dislexia y ceguera verbal congénita como sinónimos. Aunque los autores piensan que existen grandes dificultades para diferenciar entre afección congénita y afección adquirida.

Quirós (1962), diferencian la dislexia del retraso en la adquisición de la lectura y la escritura creyendo que este último es debido a un error pedagógico y medioambiental.

En abril del 1969, el grupo de investigación de la dislexia de evolución (al que pertenecía Quirós) que dependía de la Federación Mundial de Neurología, estableció las siguientes definiciones:



DEFINICIÓN

Dislexia en la infancia

Perturbación observada en niños que, a pesar de la experiencia escolar recibida, fracasan en conseguir las capacidades lingüísticas de lectura, escritura, deletreo y ortografía, que se esperaba, de acuerdo con sus habilidades intelectuales.



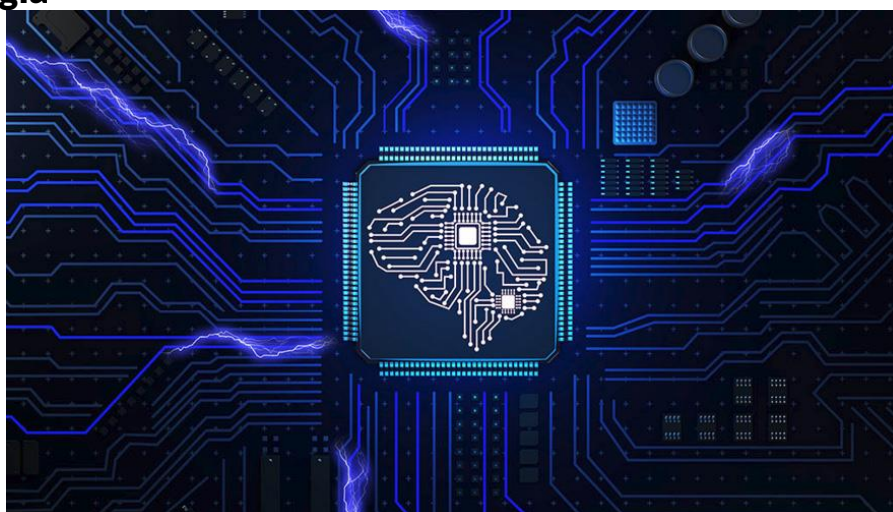
DEFINICIÓN

Dislexia específica de evolución

Perturbación que se manifiesta por presentar dificultades en el aprendizaje de la lectura, aunque haya recibido una adecuada escolarización, inteligencia, estimulación sociocultural. Como consecuencia de dificultades cognitivas fundamentales que son frecuentemente de origen constitucional.

AÑO	AUTOR	CONCEPTO DE DISLEXIA
1887	Berlin	Ligado a aspectos visuales y espaciales más que a percepciones auditivas y temporales. La dislexia se conocía con el nombre de "Ceguera verbal de carácter congénito".
1910	Mc. Cready	Afirma que la sordera, la ceguera visual congénita, el retraso del habla y la disfemia tienen un origen común; las variaciones biológicas en los centros cerebrales superiores. Sus síntomas serían problemas de lateralidad y de dominancia cerebral.
1917	Hinshelwood	Cree que es debido a un déficit visual y lo llama: "ceguera congénita". Este autor remarca la importancia de la herencia y la diferencia estadística entre la prevalencia por sexos 8:1 (niños/niñas).
1925	Orton	Da una mayor importancia a la fisiología del cerebro y a la dominancia cerebral(inmadurez cerebral).
1959	Herman	Plantea el problema como una disposición innata hacia la confusión espacial y direccional.
1962	Birch	Plantea el problema en términos de disfunción en la integración de la información proveniente de los diversos sistemas sensoriales.
1970	Ingram	Expone que la raíz de los problemas de lectura se encuentra en un déficit lingüístico.
1979	Vellutino	Cree que es debido a problemas de integración o conexión de la información aportada por las diferentes modalidades sensoriales. Se centraba en problemas de aprendizaje de la lectoescritura, afirmando la existencia de lectores buenos y lectores malos.

Etiología



La mayoría de los autores creen que la etiología de la dislexia es multifactorial, es decir, que la pueden provocar diversos factores. En la actualidad se considera la dislexia principalmente como un trastorno fonológico de origen neurobiológico y multifactorial, aunque a continuación, veremos algunos enfoques que se han propuesto en las últimas décadas.

La dislexia se manifiesta si el niño sufre alguno de los siguientes trastornos: mala lateralización, alteraciones de la psicomotricidad, conocimiento deficiente del esquema corporal, desorientación en espacio y tiempo, trastornos de la percepción (auditiva y visual), importancia de la herencia, dice Fernanda Fernández Baroja.

Para E. Torres de Bea (1977) los factores que pueden causar la dislexia tienen un carácter mucho más general, indicando que la puede provocar cualquier aspecto que afecte a la vida del niño durante el primer período: Enfermedades graves durante los primeros meses o prematuridad, lesiones neurológicas (parálisis cerebral, meningoencefalitis, poliomielitis, epilepsia), separaciones precoces muy traumáticas, ambiente emocional muy perturbador o ambiente que no proporciona un marco de referencia consistente durante los primeros años, madre constante, pero poco estructurante y herencia.

Como podemos observar, este autor pone un mayor énfasis en las causas exógenas (el entorno que envuelve al niño), que no en las endógenas, aunque también las nombre de pasada. Además, realiza una compilación de todas las posibles teorías existentes, afirma que 77% de los autores se inclinan más hacia alguna forma de explicación endógena y el resto sitúa el problema fuera del niño.

Estienne, en 1982, realiza una clasificación de las teorías explicativas y las agrupa en siete grandes grupos:

Dificultades instrumentales funcionales: hace referencia a la inmadurez de ciertos aspectos considerados necesarios para un buen aprendizaje de la lectoescritura (postura de la mayoría de los logopedas franceses).

Debido a trastornos constitucionales o hereditarios (postura de la mayoría de los médicos).

Los trastornos en el aprendizaje de la lectoescritura se consideran como un caso más del amplio abanico de trastornos del lenguaje, y su interpretación se lleva a cabo desde un enfoque psicolingüístico que combina los elementos comunes a la comunicación oral y escrita y las características específicas de esta última, en función del código escrito utilizado.

Debido a una disfunción cerebral mínima: incluyen a la dislexia en cuadros generales, con relación a determinadas características neurológicas.

Algunos autores de los años 1960-1970 creen que la dislexia es el síntoma de un trastorno más profundo de la personalidad, que no permite al niño afirmarse, aprender conductas nuevas ni adaptarse a la escuela. Por contra, otros autores piensan que la dislexia es la causante de estos trastornos de la afectividad y la conducta social, debido a la angustia y el estrés que crea la obligación del aprendizaje de la lectoescritura durante los primeros años de escolarización.

Las dos últimas explicaciones/concepciones de la dislexia son de carácter exógeno. La primera sostiene que la escuela es la responsable del rechazo que presentan algunos alumnos en este aprendizaje, y que se traduce en un aprendizaje insuficiente; esta corriente es defendida por psicólogos escolares y sociólogos, relacionando el fracaso escolar con los niveles socioculturales de los niños.

La última se centra en los métodos de aprendizaje, aunque la gran mayoría de autores piensan que no son los métodos sino la manera de aplicarlos.

A partir de 1990, empezaron a surgir con gran fuerza las investigaciones en psicología cognitiva para explicar las causas de la dislexia; Luis Lozano, en un artículo de 1990, nos explica la existencia de dos teorías para explicar las causas.

La primera cree que la dislexia está causada por una sola causa, que podría ser: un trastorno perceptivo-visual (de causa neurológica, una disfunción cerebral mínima, un inadecuado movimiento ocular, un rendimiento menor de la memoria inmediata). Mientras que, a segunda teoría cree que está causada por una pluralidad de factores, y son los defensores de esta teoría los que se sustentan con la psicología cognitiva y, más específicamente, con la teoría del procesamiento de la información: trabajan a partir de un modelo de lectura (modelo de la doble ruta de Coltheart, 1978), para descubrir dónde falla el niño que sufre de dislexia, y cuáles son las causas que le impedirían adquirir las habilidades de la lectura. Defior y Ortúzar (1993) creen que ha habido a lo largo del tiempo tres teorías principales:

Déficits visuales (de base neurológica): se hablaba de ceguera congénita para las palabras.

Déficit intelectual general: pero este aspecto se descartó, porque en la definición de dislexia queda claro que no tiene que haber problemas en este sentido.

Déficit lingüístico: que es la teoría que los autores defienden, y que está de acuerdo con la teoría descrita por Luis Lozano, es decir, se basan en la diferencia existente entre los buenos y los malos lectores, en cuanto al desarrollo de habilidades que impliquen percepción, memoria, decodificación y segmentación del lenguaje.

En 1990, algunos autores de las Universidades de Yale y de Texas, que han defendido la teoría de una base neurológica en la dislexia, se dedicaron a estudiar las diferencias que hay entre el cerebro de una persona disléxica y el de una persona sin este tipo de trastorno. A partir de sus estudios, afirman que el cerebro de las personas disléxicas presenta diferencias significativas en sus patrones de activación cerebral: una menor activación en la parte posterior del cerebro y una sobre activación en la parte frontal.

Resumiendo, podríamos afirmar que existen tres corrientes que explican las causas de la dislexia:

- **De tipo genético y neuroanatómico**

Se refiere a la manera en que el cerebro procesa la información (el cerebro de los disléxicos la procesa de manera diferente) o bien en la existencia de una alteración en la memoria a corto plazo. También existen estudios donde se ha hallado una diferencia de tamaño en disléxicos, los cuales presentaban el hemisferio izquierdo más pequeño; otros estudios muestran que hay una activación menor en este mismo hemisferio.

➤ **De tipo psicolingüístico**

Se refiere a los procesos que implican representaciones internas (pensamiento, memoria, percepción y lenguaje). Se basan en la psicología cognitiva y, concretamente, en el procesamiento de la información.

➤ **De tipo perceptivo visual**

Se refiere a problemas en percibir las formas, en el proceso de llegada de la percepción al cerebro, alteración en los movimientos sacádicos.

Según Ronald D. Davis, algunas personas nacerían, aparentemente, con un código genético que les permite utilizar la parte de su cerebro que altera y crea las percepciones. Tener ese código genético no produciría la dislexia, sólo daría la posibilidad de desarrollarla. Esta teoría explica por qué parece que la dislexia sigue líneas hereditarias.

El disléxico empezaría a utilizar la capacidad para alterar las percepciones, quizás, a la temprana edad de tres meses. En su opinión, cree que, si un niño comienza a usar la función cerebral de distorsión antes de los tres meses, los problemas resultantes serán mucho más severos que la dislexia. Podría dar como resultado percepciones tan imprecisas, que la persona no llegará a relacionarse de forma normal con el mundo exterior; siendo muy probable que esa persona termine siendo etiquetada como autista o discapacitado intelectual.

Ese «talento mental» que usa el disléxico en potencia, para reconocer un objeto, parece que nunca comete errores. Sus percepciones «autocreadas» siempre parecen tan precisas como lo es el propio objeto. Tiene una gran habilidad para completar mentalmente percepciones fragmentarias.

Ese pequeño disléxico en potencia, de tres meses, es capaz de reconocer cosas de su entorno que no debería poder reconocer hasta dentro de tres años. Esta habilidad que tiene para reconocer objetos reales de su entorno influenciará el resto de su desarrollo, desde la niñez.

Quirós piensa que pueden existir factores predisponentes determinantes para algunos niños. La mayoría de los autores están de acuerdo en que debe existir un factor constitucional en la etiología de la dislexia. Hallgren (1950), en un estudio donde observó a 273 disléxicos, llegó a la conclusión de que la «dislexia específica de evolución» se debe a un factor hereditario resultante de un gen mono híbrido dominante autosómico con una manifestación prácticamente completa.

La dislexia puede presentarse como un síntoma de trastornos mentales, deficiencias intelectuales y afasias adquiridas; se puede llegar a confundir con deficiencias visuales o auditivas y con perturbaciones psicológicas. Cuando se presenta acompañando a síntomas psicológicos o neurológicos, el cuadro clínico se parece bastante al daño cerebral leve y también a lo que autores europeos y norteamericanos denominan como «lesión cerebral mínima», «disfunción cerebral», «síndrome psicomotora».

Estos síndromes neurológicos podrían ser determinantes para el daño cerebral o para la alteración genética. Este cuadro se presenta, sobre todo, con trastornos referentes al esquema corporal, la dominancia lateral, la noción de tiempo y espacio, la actividad general del niño y la existencia de pequeños datos patológicos en el examen neurológico final. A este cuadro psiconeurológico, se le añadirán perturbaciones de la misma organización del habla y del lenguaje.

Se da por sabido que estas perturbaciones del lenguaje pueden presentarse también juntamente con síntomas psiconeurológicos, como en las llamadas afasias infantiles; les pareció conveniente sostener que el síndrome de «deficiencia de organización del lenguaje» (con manifestaciones psicomotrices concomitantes), representaba, en realidad, una forma leve de disfasia, es decir, para Quirós y las dislexias severas (o dificultades severas para la adquisición de la lectura) son verdaderas disfasias leves.

Se hablará de disfasia infantil, cuando la dislexia se presenta como un síntoma postlesional. Este tipo de disfasia o afasia predomina con una desorganización del lenguaje. La «dislexia específica de evolución», sería un síndrome (como apuntábamos en el apartado de definición del concepto) que forma parte de otro síndrome más extenso el «síndrome ISLOI» (o síndrome de deficiencia de organización del lenguaje infantil). Dentro de las enfermedades que incluyen este síndrome, se encontrarán los síndromes de perturbación del lenguaje lectoescriptor, y dentro de este síndrome, la patología de la dislexia.

Para la mayoría de los psicólogos, las perturbaciones en la adquisición de la lectura son consecuencia de diversos factores y no de uno solo. Sería muy difícil que un factor aislado fuese suficiente como para inhibir el acto de leer.

Clasificación de la dislexia



El síndrome de la dislexia se manifiesta mediante una amplia variedad de síntomas. Por esta razón, los expertos en diferentes campos proporcionan definiciones diversas. Es por esta misma razón que, a lo largo de todos estos años de investigación de los diferentes autores y teorías, ha ido variando el tipo de clasificación que se hacía sobre esta patología.

Actualmente, la clasificación más generalizada y aceptada por la mayoría de autores es la que formuló Coltheart y Castle, la cual explicamos a continuación:

**Dislexia fonológica o auditiva**

Fallaría la ruta fonológica. El niño presentaría unas características determinadas:

Errores de correspondencia fonema-grafema.

- Será capaz de visualizar globalmente la palabra, pero no podrá

segmentarla.

- Mayor facilidad para leer las palabras más frecuentes, familiares.
- Errores en la lectura de pseudopalabras, porque estas no aparecerán en su lexicón. Presentará «regularizaciones», es decir, leerá la palabra que tenga en su lexicón y que será lo más parecida posible a la que ha de leer.
- Problemas en las formas verbales; al leer, el niño procesa la información por vías diferentes. La raíz, por la ruta visual, y la flexión por la ruta auditiva (el lector leerá la raíz del verbo y colocará la terminación que le parezca la más correcta).
- Presenta dificultades para leer los nexos de unión o las palabras función, porque estas no tienen la representación semántica, las omitirá o las cambiará.
- Cometerá errores en palabras parecidas, confundiéndose, porque con un golpe de vista se parecen mucho (por ejemplo: casa/cosa).
- Presentará una mayor dificultad cuanto más larga sea la palabra, porque le será mucho más difícil retenerla.



Dislexia superficial

También conocida como visual o léxica, normalmente, en la lengua española, no se da este tipo de dislexia, la lengua inglesa presenta mayores problemas. Las personas con este tipo de dislexia funcionan bien haciendo un reconocimiento de las palabras por la ruta fonológica, es decir, estas personas serán capaces de leer palabras más largas y menos familiares. Cometerá errores de este tipo:

- Confusión de palabras homófonas (vaca/baca), ya que el acceso al léxico está guiado por el sonido y no por la ortografía de la palabra.
- Errores de omisión, adición y sustitución de letras.
- Dificultad en la asociación del signo gráfico con su significado (dificultad de retención de palabras en su lexicón).



Dislexia profunda o mixta

Las personas afectadas presentan dificultades en las dos rutas. El pronóstico de rehabilitación es mucho menos favorable que en los otros tipos, porque el afectado no tiene ninguna de las dos rutas preservadas y esto dificultará su tratamiento. Sus características serán:

- Incapacidad para la lectura de pseudopalabras (dificultad fonológica).
- Dificultad para el acceso al significado de las palabras (dificultad léxica).
- Presenta errores visuales y derivados (dificultad fonológica).
- Presenta dificultad en palabras abstractas, palabras función (dificultad fonológica).
- Aparición de numerosos errores semánticos o paralexias (confusión, reemplazando las palabras por otras parecidas en el sentido, en la forma o en la escritura. Por ejemplo: «asno» por «burro», «feliz» por «navidad»). Este tipo de errores son definitorios de esta dislexia.

AÑO	AUTOR	TIPO DE DISLEXIA
1967	Johston & Myklebust	Dislexia Visual Dislexia Auditiva
1973	Dr. Boder	Dislexia Diseidética o visual Dislexia Disfonética o auditiva Dislexia Aléxica o Mixta
1974	Fernández Baroja	Dislexia Madurativa Dislexia Evolutiva

AÑO	AUTOR	TIPO DE DISLEXIA
1977	E. Torras de Bea	Dislexia con trastornos del pensamiento verbal y prático Dislexia con trastornos del pensamiento verbal, pero con conservación del pensamiento prático
1980	M. Nieto	Dislexia a nivel de problemas mecánicos Dislexia a nivel de los procesos de integración Dislexia a nivel de desintegración total fonémico-gráfico
1983	Pollasteck	Dislexia Visual Dislexia Auditiva
1987/88	Pirozzolo & Rayner	Dislexia Viso-espacial Dislexia Auditivo-lingüística
1993	Coltheart & Castle	Dislexia Fonológica o Auditiva Dislexia Visual, Superficial o Léxica Dislexia Profunda o Mixta

Davis (1994) propone una nueva perspectiva, donde habla de imágenes tridimensionales, de desorientaciones, confusiones y de palabras detonantes. En su libro *El don de la dislexia*, nos explica que los seres humanos pueden generar sus pensamientos de dos formas diferentes, conocidas como: conceptualización verbal y conceptualización no verbal.

- El pensamiento verbal es lineal. Sigue la estructura del lenguaje. Al utilizarlo, la persona compone oraciones mentales con una palabra tras otra. El pensamiento verbal se produce casi a la misma velocidad que el habla.
- El pensamiento no verbal es evolutivo. La imagen «crece» a medida que el proceso de pensamiento agrega más conceptos. De hecho, es difícil entender el proceso del pensamiento no verbal, porque sucede tan rápido que es imposible percatarse. El pensamiento no verbal es, por lo general, subliminal y está fuera del alcance de la conciencia.

Las personas pensamos de las dos formas, aunque cada persona escoge una de las dos modalidades como su modo primario de pensamiento, y la otra como el secundario. Durante el período en el que se forma la dificultad en el aprendizaje propio de la dislexia, entre los tres y los trece años, el disléxico potencial es básicamente, un pensador no verbal: una persona que piensa en imágenes.

Para poder apreciar cómo contribuye este modo de pensamiento a la dificultad de aprender, demos un vistazo a nuestro lenguaje. Este se compone de símbolos, cada uno de los cuales tiene: sonido, significado y representación.

Cuando utilizamos la conceptualización verbal, pensamos con los sonidos del lenguaje. En realidad, sostenemos un monólogo interno. Si utilizamos la conceptualización no verbal, pensamos lo que significa el lenguaje mediante la formación de imágenes mentales de los conceptos e ideas. Estas no son solamente estáticas, son más bien películas tridimensionales, multisensoriales.

Para los disléxicos, el monólogo interno es escaso o nulo. No oyen lo que están leyendo, a menos que estén leyendo en voz alta. En su lugar, componen una imagen mental agregando el significado, o la imagen del significado, de cada nueva palabra que se van encontrando.

Las palabras que describen cosas o acciones reales no causan problemas a los disléxicos, ya que para el pensamiento no verbal es fácil pensar en la palabra elefante, si ya conoce cómo es el elefante. Sin embargo, para un pensador no verbal, es imposible pensar con palabras cuyos significados no se puedan traducir en imágenes. Por ejemplo, ver las letras «e-l-» de la palabra «el» no quiere decir que comprendan su significado. Este tipo de palabras: un, el, la, a, para (es decir las palabras función, palabras con significados abstractos, palabras desconocidas y palabras con varios significados) funcionan como palabras detonantes, como explicaremos más adelante.

Ronald también la «orientación», que se refiere a saber dónde estamos con relación al entorno. En términos de percepción, significa captar los hechos y las condiciones de tu alrededor y colocarte en relación correcta con ellos. Proponemos el siguiente experimento:



REFLEXIÓN

Cierra los ojos y mira una imagen mental imaginaria (una casa, un pastel). ¡Ya! ¿Has abierto los ojos? Piensa, ¿dónde se encontraba el punto de percepción? (Este es el mismo al cual se refiere el autor). ¿Crees que se halla en el punto desde donde estás mirando (los ojos), o desde lo que estás utilizando para poder ver (la mente)? Comprenderemos el concepto un poco más adelante, para entenderlo, hemos de explicar antes otros conceptos como el siguiente.

Si bien la desorientación es una experiencia común, los disléxicos la llevan más allá de lo ordinario. No sólo experimentan desorientación, sino que la ocasionan sin darse cuenta. Usan la desorientación en un nivel inconsciente como modo de percepción en forma multidimensional. Al cambiar mentalmente la posición de sus sentidos (el punto desde donde miran), pueden experimentar panorámicas múltiples del mundo. Perciben cosas desde más de una perspectiva y obtienen, a partir de estas percepciones, más información que otras personas.

**DEFINICIÓN****Desorientación**

La desorientación es una función natural más de cualquier cerebro normal. Se produce cuando estamos abrumados por los estímulos o los pensamientos, y también cuando el cerebro recibe información conflictiva desde distintos sentidos y trata de correlacionarla.

Debido a que estas percepciones alteradas añadidas facilitan el reconocimiento de objetos, que de otra forma serían irreconocibles, la desorientación se convierte en una parte normal de su proceso de pensamiento. Los disléxicos no se dan cuenta de lo que sucede durante la desorientación, porque transcurre con demasiada rapidez. Sólo son conscientes de lo que consiguen cuando la utilizan: hay un reconocimiento mejor de los objetos tridimensionales, los sonidos y los estímulos táctiles.

El disléxico no percibe lo que en realidad está escrito sobre una página, sino lo que piensa que está sobre el papel. En el proceso de lectura de una frase mediante la conceptualización no verbal, se desencadenan las siguientes dificultades: la imagen de su significado evoluciona mientras se lee la frase. El progreso evolutivo, de la imagen que se está formando al leer la frase, se detiene cada vez que el significado llega a una palabra desconocida, porque sin una imagen esa palabra no puede ser incorporada a la imagen general. El problema se agrava cada vez que aparece una palabra cuyo significado no tiene una imagen mental correspondiente. El proceso concluye con una serie de imágenes sin relación entre ellas, separadas por espacios en blanco.

Cada vez que el proceso de creación de imágenes se interrumpe, la persona experimenta un sentimiento de confusión, porque la imagen que está componiendo se hace cada vez más incoherente. El lector ocupa subliminalmente los espacios en blanco, y sigue adelante gracias a un esfuerzo de concentración, pero sólo consigue estar más y más confundido conforme avanza. Al continuar así, pronto alcanza su umbral de confusión. Es en este punto cuando la persona se desorienta.

La desorientación implica que, en ese momento, la percepción se altera y distorsiona de tal forma que los símbolos, la lectura y la escritura, resultan difíciles o imposibles de utilizar.

**ANEXO**

Vamos a experimentar la odisea de una persona con dislexia, para ello, ilustramos la explicación que se puede encontrar en el siguiente anexo con una frase **«El caballo marrón saltó sobre la valla de piedra y corrió a través del prado»**

[El caballo marrón](#)

Diagnóstico



La mayoría de los autores coinciden en la importancia de realizar un buen diagnóstico precoz, para poder comenzar la rehabilitación lo más pronto posible. También, es de gran importancia hacer un diagnóstico adecuado para no confundir la dislexia con una deficiencia mental o apatía en los estudios debido a una visión superficial de la problemática del niño.

Hemos de descartar en el niño los siguientes elementos: defectos de visión, defectos en la audición, un CI (coeficiente intelectual) por debajo de lo esperado para su edad, la existencia de una perturbación emocional primaria, que el problema no sea causa de una falta de instrucción, lesiones cerebrales diagnosticables y que estas puedan afectar el área del lenguaje y el diagnóstico de retardo grave en el desarrollo.

Todavía no se han generado pruebas estandarizadas desde la perspectiva cognitiva para diagnosticar la dislexia, como vimos en otros temas. Pero se utilizan ítems o escalas de pruebas ya existentes para diagnosticar determinados factores del proceso. A parte de las estandarizadas, se pueden utilizar otras pruebas, elaboradas por nosotros mismos, que servirán para la evaluación específica de algunos aspectos concretos que están implicados en la lectura.

Como pruebas estandarizadas, podemos utilizar el WISC, que es una de las pruebas más utilizadas por la amplia información que proporcionan sus subtest y por la posibilidad de establecer un perfil. Podemos también aplicar una prueba de lectoescritura, como el TALE, que permite hacer un análisis detallado de los problemas que aparecen en todas las áreas. En problemas donde el lenguaje tiene un mayor grado de incidencia podemos utilizar el ITPA. Una alternativa para estos problemas serían las matrices progresivas de Raven.

A continuación, exponemos las pruebas estandarizadas que pueden utilizarse para obtener información entorno a la dislexia:

Tests generales de lenguaje

ITPA (Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas). Evaluación de las funciones psicolingüísticas implicadas en el proceso de comunicación y, consecuentemente, detección de trastornos de aprendizaje. Edad de aplicación: de 2,5 a 10,5 años.

PLON- R (Prueba de Lenguaje Oral de Navarra). Test que sirve de screening o detección rápida del desarrollo del lenguaje oral. Edad de aplicación: 3 a 6 años.

BLOC (Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial). Mide los 4 componentes básicos del lenguaje: morfología, sintaxis, semántica y pragmática. No mide fonología. Edad de aplicación: de 5 a 14 años.

Tests específicos de lenguaje

TSA. El desarrollo de la morfosintaxis en el niño. Indicado para evaluar el componente morfosintáctico del lenguaje. Edad de aplicación: de 3 a 7 años.

PEABODY. Evalúa el léxico del sujeto. Edad de aplicación entre 2a; 6m y 90 años.

Registro fonológico inducido: Este test evalúa la fonología en expresión inducida y en repetición. Edad de aplicación entre 3 y 7 años.

Tests específicos de lectoescritura

- PROLEC. Evaluación de los procesos lectores. Se obtiene una puntuación de la capacidad lectora de los niños e información sobre las estrategias que cada niño utiliza en la lectura de un texto, así como de los mecanismos que no están funcionando adecuadamente y por lo tanto no le permiten realizar una buena lectura. Edad de aplicación: cursos de 1o a 4o de Educación Primaria. La variante PROLEC-SE se puede aplicar desde 5o de Educación Primaria hasta cuarto de Educación Secundaria.

- TALE (Test de Análisis de la Lectura y la Escritura). Prueba destinada a determinar los niveles generales y las características específicas de la lectura y la escritura de cualquier niño, en un momento dado del proceso de adquisición de tales conductas. Edad de aplicación: de 6 a 10 años.

También se pueden utilizar los criterios de diagnósticos del DSM-5, que son los siguientes:



Primero

Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciado por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de intervenciones dirigidas a estas dificultades:

- Lectura de palabras imprecisas o lenta y con esfuerzo (lee palabras sueltas en voz alta incorrectamente o con lentitud y vacilación, con frecuencia adivina palabras, dificultad para expresar bien las palabras).
- Dificultad para comprender el significado de lo que lee (p. ej., puede leer un texto con precisión, pero no comprende la oración, las relaciones, las inferencias o el sentido profundo de lo que lee).
- Dificultades ortográficas (p. ej., puede añadir, omitir o sustituir vocales o consonantes).
- Dificultades con la expresión escrita (p. ej., hace múltiples errores gramaticales o de puntuación en una oración; organiza mal el párrafo; la expresión escrita de ideas no es clara).
- Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo (p. ej., comprende mal los números, su magnitud y sus relaciones; cuenta con los dedos para sumar números de un solo dígito en lugar de recordar la operación matemática como hacen sus iguales; se pierde en el cálculo aritmético y puede intercambiar los procedimientos).
- Dificultades con el razonamiento matemático (p. ej., tiene gran dificultad para aplicar los conceptos, hechos u operaciones matemáticas para resolver problemas cuantitativos).



Segundo

Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente y en grado cuantificable por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo, e interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral, o con actividades de la vida cotidiana, que se confirman con medidas (pruebas) estandarizadas administradas individualmente y una evaluación clínica integral. En individuos de 17 y más años, la historia documentada de las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada.



Tercero

Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo (p. ej., en exámenes

programados, la lectura o escritura de informes complejos y largos para una fecha límite inaplazable, tareas académicas excesivamente pesadas).



Cuarto

Se han de cumplir los cuatro criterios diagnósticos basándose en una síntesis clínica de la historia del individuo (del desarrollo, médica, familiar, educativa), informes escolares y evaluación psicoeducativa. Además, especificar todos las áreas académicas y subaptitudes alteradas. Cuando más de un área está alterada, cada una de ellas se codificará individualmente de acuerdo con los especificadores.

Especificar si 315.00 (F81.0) con dificultades en la lectura: precisión en la lectura de palabras, velocidad o fluidez de la lectura, comprensión de la lectura. La dislexia es un término alternativo utilizado para referirse a un patrón de dificultades del aprendizaje que se caracteriza por problemas con el reconocimiento de palabras en forma precisa o fluida, deletrear mal y poca capacidad ortográfica. Si se utiliza dislexia para especificar este patrón particular de dificultades, también es importante especificar cualquier dificultad adicional presente, como dificultades de comprensión de la lectura o del razonamiento matemático. Especificar la gravedad actual:

Leve	Moderado	Grave
Algunas dificultades con las aptitudes de aprendizaje en uno o dos áreas académicas, pero suficientemente leves para que el individuo pueda compensarlas o funcionar	Dificultades notables con las aptitudes de aprendizaje en una o más áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de llegar a ser competente sin algunos períodos de enseñanza intensiva y	Dificultades graves en las aptitudes de aprendizaje que afectan varias áreas académicas, de manera que el individuo tiene pocas probabilidades de aprender esas aptitudes sin enseñanza constante e

Leve	Moderado	Grave
bien cuando recibe una adaptación adecuada o servicios de ayuda, especialmente durante la edad escolar.	especializada durante la edad escolar. Se puede necesitar alguna adaptación o servicios de ayuda al menos durante una parte del horario en la escuela, en el lugar de trabajo o en casa para realizar las actividades de forma correcta y eficaz.	intensiva individualizada y especializada durante la mayor parte de los años escolares. Incluso con diversos métodos de adaptación y servicios adecuados en casa, en la escuela o en el lugar de trabajo, el individuo puede no ser capaz de realizar con eficacia todas las actividades.

Procesos perceptivo-visuales

Para analizar estos tipos de procesos, podemos aplicar pruebas estandarizadas como: reversal test, de Edfeldt; test gestáltico visomotor, de Bender; test de estructuras rítmicas, de Mira-Stamback; test de la figura humana, de Goodenough y test de Frostig. Para determinar si el error es de tipo perceptivo o lingüístico, podemos utilizar otras pruebas no estandarizadas; pruebas donde no sea necesario identificar y que sean, solamente, un trabajo de percepción, como, por ejemplo: tareas de asociación gráfica-sonido, deletreo oral, copia de elementos, según una muestra y ejercicios de distinción figura-fondo.

Procesos de reconocimiento de palabras

De todos los procesos implicados en el aprendizaje de la lectura, los procesos de reconocimiento de palabras son muy importantes, ya que cualquier déficit en estos provocará problemas en la adquisición de la lectura. Para acceder al léxico, ha de saber diferenciar dos rutas: la ruta léxica y la ruta fonológica. Es importante evaluar el funcionamiento de cada una de ellas y hacer constar el tipo de error que aparece para poder analizarlo (omisiones, repeticiones, sustituciones, inversiones, rotaciones). La ruta más difícil de evaluar es la ruta léxica, tanto en catalán como en castellano

Para la ruta fonológica, se utilizarán pseudopalabras para detectar los problemas; y se tendrá en cuenta que aparezcan todos los grafemas, la longitud de las pseudopalabras y la situación de los grafemas dentro de estas. La mayoría de los niños tienen problemas en esta segunda ruta: podrán leer palabras familiares a través de la ruta léxica, pero tendrán dificultades con las palabras desconocidas y con las pseudopalabras.

Procesos de comprensión

Un buen lector ha de saber cómo se relacionan y cómo se combinan las palabras para formar oraciones y, a la vez, poder extraer el significado de un enunciado o

discurso. Son muchos los factores que se relacionan en este proceso de comprensión y van desde los procesos cognitivos hasta los conocimientos previos del propio lector. Así, entonces, se observarán aspectos tales como:

- Elementos sintácticos
Capacidad para combinar unidades, juicios de corrección de oraciones, complejidad de la oración y tareas de cierre gramatical.
- Elementos semánticos
Utilización de técnicas para extraer y organizar la información, extraer el significado, integración del significado en sus conocimientos y conocimientos del lector.

Ronald D. Davis, autor de El don de la dislexia, critica el método tradicional para diagnosticar, ya que este se basa en el estudio de los síntomas; lo cual plantea muchos problemas. El primero es que dos personas con dislexia no presentan los mismos síntomas.

Si consideramos la dislexia como un proceso de desarrollo, las anomalías que presenta el disléxico serían el resultado de la forma diferente en que se desarrolla su cerebro por el uso distinto que de él hace. Como resultado, podemos concluir que no existe ningún examen definitivo de diagnóstico para la dislexia.

Si consideramos la estructura o anatomía del problema de aprendizaje llamado dislexia, descubriremos que sigue esta secuencia en su desarrollo:

- 01** El individuo topa con un estímulo irreconocible (una palabra escrita o hablada, un símbolo, un objeto).

La falta de reconocimiento origina confusión que, a su vez, estimula la desorientación. El individuo usa esta desorientación para examinar el estímulo confuso mentalmente desde diferentes puntos de vista (serviría con objetos, pero no con el lenguaje). **02**
- 03** La desorientación causa la percepción y asimilación de datos incorrectos (aunque quedan registrados en su cerebro como percepciones verdaderas; sin embargo, la mayoría son incorrectas).

La asimilación de información incorrecta le lleva a cometer errores (son, por lo general, los primeros síntomas de la dislexia). Los errores originan reacciones emocionales. **04**
- 05** Las reacciones emocionales terminan en frustración.

Se generan o adoptan soluciones incorrectas, para dar salida a los problemas derivados del uso de la desorientación, en el proceso **06**

del reconocimiento (métodos utilizados para dar apariencia de conocer las cosas o desempeñar las tareas, surgiendo el comportamiento compulsivo).

- 07** La inhabilidad para aprender está compuesta por las soluciones compulsivas que adquiere el individuo. Estas soluciones compulsivas, impropias, son las que impiden el proceso de aprendizaje.

Aunque en un principio, el autor critica el hecho de fijarse en los síntomas, cree que debemos estar familiarizados con los más conocidos. Afirma que todos los síntomas de la dislexia son síntomas de desorientación, durante esta, las percepciones se distorsionan. Los sentidos principales que se distorsionan son la vista, el oído, el equilibrio, el movimiento y el tiempo.

Algunos ejemplos comunes de la desorientación incluyen el mareo, la sensación de caer cuando se está en una escalera mecánica o al borde de un acantilado, oír cosas, o falsa sensación de movimiento que se experimenta cuando estamos sentados dentro de un vehículo detenido y vemos que otro cercano se mueve. Además, proporciona una lista de algunos de los síntomas más comunes de desorientación catalogados según las percepciones sensoriales más afectadas.

❖ **Vista**

Formas y secuencias de letras y números cambiadas o invertidas: se salta palabras o renglones, cuando lee o escribe. Parece como si letras y números se mueven, desaparecen, crecen o encogen. Omite los signos de puntuación (los ignora o no los ve). Altera, omite o sustituye las palabras o letras al escribir.

❖ **Oído**

Dificultad para emitir algunos sonidos hablados: pronuncian mal las dobles grafías (ch, ll, rr), pronuncian mal las combinaciones (que, qui, güe, güi, gue, gui), perciben sonidos falsos, parece que no escuchan lo que se les ha dicho y los sonidos se perciben más bajo o alto, o lejos o cerca de lo real.

❖ **Equilibrio**

Mareo al leer, pobre capacidad de orientarse, dificultad para quedarse quieto, dificultad para escribir a mano y problemas con el equilibrio y la coordinación.

❖ **Tiempo**

Hiperactividad, hipoactividad, dificultad de aprendizaje de conceptos matemáticos, dificultad para llegar a tiempo o decir la hora,

excesivamente imaginativo, pierde el hilo de los pensamientos fácilmente y problemas de secuenciación.

Además, presentan una serie de comportamientos compensatorios, patrones o estrategias mentales que crea como soluciones compulsivas, impropias, ya que lejos de solucionar sus problemas, detienen su capacidad de aprender. He aquí las más comunes: memorizar el alfabeto a partir de la «a», en voz alta o mentalmente, concentración extrema al leer, memorización, posturas o movimientos corporales poco usuales, dependencia de otros, pronunciar cada letra de cada palabra en voz alta y eludir.

Davis cree que si, además de los síntomas típicos de desorientación, la persona posee alguna de las siguientes habilidades y también presenta inhabilidad para aprender, cree con toda seguridad que está delante de un disléxico. Las habilidades son las siguientes; estas son compartidas por todos los disléxicos y serían los talentos que formarían parte del «don» de la dislexia:

01 La habilidad para activar intencionalmente, en el cerebro, la función de distorsión perceptiva (o percepción distorsionada).

La habilidad de visualizar conscientemente las imágenes mentales de forma tridimensional, y de moverse alrededor de ellas dentro del propio espacio mental. **02**

03 La habilidad de experimentar imágenes mentales auto creadas, como fenómenos del mundo real; en otras palabras, experimentar la imaginación como realidad.

La tendencia o preferencia de pensar en forma no verbal, con imágenes de conceptos e ideas y poco o nulo monólogo interior. **04**



REFLEXIÓN

En su clínica utiliza con sus pacientes la «Prueba de Evaluación de la Habilidad Perceptiva», para determinar si una persona tiene la habilidad de mover el ojo mental (lo que ve las imágenes mentales que uno se hace. El ojo de la mente es lo que ve dentro de nuestra imaginación) con facilidad, y de ver una imagen mental desde diferentes perspectivas en el espacio. En otras palabras, **¿puede esa persona producir la desorientación intencionadamente?**

Intervención



Para que exista una recuperación positiva en el niño disléxico, es necesario un diagnóstico precoz, una intervención temprana y pedagogía de mantenimiento. La corrección tendría que empezar en edad preescolar, pero la realidad es que no es hasta los primeros cursos de escolaridad donde se manifiesta. Igualmente, es en etapas posteriores donde se encuentran niños y niñas con secuelas de una dislexia mal corregida.

Es por esta razón, que creemos importante intervenir en tres niveles diferentes:

➤ **Nivel de iniciación**

Donde los ejercicios van encaminados a prevenir las dificultades y alteraciones que se supone que aparecerán en el aprendizaje de la lectoescritura. La recuperación en esta etapa se basará en ejercicios de lenguaje, de grafía, de aprendizaje del esquema corporal, sensorio-perceptivos y motrices.

➤ **Nivel escolar**

Los niños que hayan superado la etapa preescolar se encuentran con nuevos obstáculos que dependen de las exigencias escolares. Los ejercicios en esta etapa irán encaminados a afianzar el esquema corporal y los aspectos espacio-temporales.

➤ **Nivel de afianzamiento**

Los niños que han sido intervenidos desde el primer momento llegan a los 9-10 años con secuelas. Su lectura podrá ser comprensiva, pero será extremadamente lenta y poco expresiva, la ortografía será deficiente y su expresión verbal será pobre.

La vertiente más innovadora en el tema de intervención es la que hace referencia a la psicología cognitiva y a los diferentes procesos lectores; a partir

de aquí, tal y como apuntan algunos autores, entre ellos Defior y Ortúzar (1993), se tendrá que incidir en cada niño, de forma individual, en el proceso o procesos que tengan alterados y que le dificulten el acceso a la lectura. Estos son los que tratamos a continuación.

Procesos perceptivos

Procesos de reconocimiento de palabras, si el niño tiene problemas para acceder a la lectura a partir de la ruta léxica, el objetivo a conseguir será que el niño obtenga una representación léxica de la palabra, desarrollando la conexión con el sistema semántico para recuperar su significado. Para conseguir este objetivo, le podremos ayudar utilizando diferentes claves (gestos, dibujos, signos, colores) y diferentes sensaciones (tacto, movimiento), que irán disminuyendo a medida que el niño vaya adquiriendo las estrategias, hasta hacer que desaparezcan del todo.

Si el niño tiene problemas con la ruta fonológica, se practicarán unas actividades encaminadas al aprendizaje de la segmentación y al análisis de las palabras en sus unidades y su asociación con los grafemas correspondientes. Pero antes de planificar estas actividades, se han de contemplar las siguientes consideraciones generales:

01 Segmentar primero las oraciones en palabras, después las palabras en sílabas y, por último, las sílabas en fonemas.

Cuando trabajamos con los fonemas, se partirá de las vocales y después las consonantes.

02

03 En cuanto a las sílabas y los fonemas, se tendrá en cuenta su posición y el tipo, sabemos que le será más fácil trabajar las sílabas iniciales y finales y, posteriormente, las intermedias, y que los fonemas oclusivos le serán más complicados que los otros, debido a que su pronunciación es mucho más difícil sin apoyo vocálico.

Se partirá de palabras concretas y familiares para el niño, que se puedan representar acompañadas de dibujos.

04

Las actividades que se tienen que realizar para recuperar los déficits, en estos procesos, tienen una doble vertiente: por un lado, los de carácter sintáctico, que tendrán como objetivo conseguir asignar los correspondientes papeles gramaticales a las palabras funcionales; y por otro, de carácter semántico: conseguir que extraiga el significado global de un texto y ordenar la información que presenta.

**ANEXO**

Para realizar las actividades, se puede utilizar material que existe en el mercado como lotos, láminas, aunque la mayoría puede ser creado por el propio profesional. Estas actividades las podrán encontrar en el anexo, junto a las de los problemas con ruta fonológica.

[Actividades de los procesos de reconocimiento de las palabras y la ruta fonológica](#)

Procesos sintácticos

Se tendrá en cuenta la complejidad de las frases; que al principio de las tareas irán acompañadas de claves externas, que irán desapareciendo a medida que los sujetos vayan progresando:

Es necesario buscar tareas de relacionar dos palabras, teniendo en cuenta las reglas de concordancia gramaticales (género, número, tiempo y persona), emparejar dibujo-oración, separar los elementos de las oraciones: lectura de frases donde los grupos sintácticos están marcados (coloreados, separados por una raya), formar oraciones que tengan relación con dibujos presentados, siendo necesaria la elección de algún grupo sintáctico, formar frases a partir de grupos sintácticos desordenados, completar oraciones; donde tendrá que escoger un grupo sintáctico, de entre unos cuantos. Señalar la frase correcta de entre varias, siendo la diferencia mínima (una palabra funcional, un error de concordancia), automatización de los signos de puntuación.

También lectura de frases: progresivamente, se irán representando frases de menor a mayor longitud, acompañadas de diferentes claves (tamaño grande de los signos, mayor separación de los grupos sintácticos, hacer un gesto diferente para cada signo de puntuación), realizar teatro (leído) y puntuar frases y textos a los cuales les falten los signos de puntuación.

Procesos semánticos**Técnicas para extraer y organizar la información:**

- | | | |
|-----------|---|-----------|
| 01 | Identificar las ideas importantes o la información esencial del texto, utilizando el subrayado de estas. | |
| | Acompañar los textos con dibujos alusivos. | 02 |
| 03 | Actividades para identificar la estructura de los textos narrativos: tema, personajes, situación conflictiva, soluciones. | |
| | Actividades para identificar la estructura de los textos (expositivos, comparativos, descriptivos, secuenciales). | 04 |
| 05 | Enseñar a realizar buenos resúmenes, esquemas y mapas conceptuales de diferentes tipos de textos. | |

Tareas para aumentar la comprensión:

- Activar los conocimientos previos a la lectura del texto.
- Formular preguntas, a medida que va leyendo, induciendo al propio sujeto que sea él mismo quien se las haga.
- Formular preguntas antes, durante y al finalizar la lectura.
- Prestar atención al título y subtítulos, para poder prever el contenido de un texto.
- Escoger un final para un texto inacabado.
- Una vez leído un texto, escoger un título de entre varios.
- Localizar una frase que no tenga relación con el texto.

Tareas para relacionar la información con sus conocimientos:

01 Localizar la palabra que no tiene relación con otras que forman parte de una familia o que tienen la misma categoría semántica.

Escoger una palabra, de entre unas cuantas, que corresponda a una definición dada.

02

03 Lectura de textos: se empezará por textos sencillos y familiares para el niño, como pueden ser cuentos, para continuar con textos más complicados, como son los expositivos. Se puede acompañar el texto con algún dibujo, para ayudar a su comprensión o explicar de qué trata, y, posteriormente, formular preguntas para que manifieste sus conocimientos sobre algún tema que haga referencia al texto leído.

Lectura funcional: se presenta, de manera escrita, informaciones que se pueden encontrar en etiquetas de ropa, carteles, menús, recetas de cocina. El sujeto tendrá que responder a preguntas relacionadas con el contenido de estos textos.

04

05 Completar textos: dar una lista de palabras relacionadas por una característica; el niño tendrá que leer el texto, colocando cada palabra en el lugar correspondiente.

Para el diseño de un plan general para el tratamiento de la dislexia, Quirós se basa, en primer lugar, en la reeducación de la lectoescritura, pero tiene en cuenta que el niño deberá tener ya adquiridos ciertos conocimientos.

Quirós argumenta que la correcta evolución en la motricidad y en las percepciones es indispensable para una buena formación del esquema corporal y que esto hará posible que el niño sea capaz de hacer una adaptación mejor en el mundo y desarrolle correctamente sus facultades intelectuales y de aprendizaje. Su argumento se basa en un principio general de la evolución, donde se cree que no pueden existir «vacíos» en las diferentes etapas evolutivas del desarrollo. En caso de que existiesen, estos «vacíos», más pronto o más tarde

serían “llenados”. Es decir, que estos «vacíos» se manifestarán más tarde como deficiencias en la adquisición de los conocimientos.

Un niño pasó de la posición de sentado a la de caminar, sin haber pasado por la etapa anterior del gateo, más tarde y en los años de escolarización, se evidenciaron desorientaciones espaciales en la escritura.

Quirós, antes de planificar su terapia (individual para cada persona), revisa cómo han sido todos los períodos evolutivos del sujeto y readapta, si hiciera falta, las diferentes etapas dentro del plan educativo. Es decir, si presume la existencia de una deficiencia primaria en la habilidad para escuchar o ver, su intervención se orientará hacia la rehabilitación de estos sentidos. En el caso del ejemplo anteriormente citado, la intervención realizada va a actuar sobre la organización espacial, apoyándose sobre la base de ejercicios corporales adecuados.

Plan de reeducación

Fija algunos factores para tener en cuenta para el diseño del plan de reeducación como los datos de la anamnesis, este permitirá informarnos sobre la existencia de diversos factores que pueden determinar distintas orientaciones reeducativas.

El autor, hace referencia a la diferencia entre las orientaciones hacia la rehabilitación de la dislexia de causa genética (tratamiento mucho más prolongado) y la dislexia debida a factores psiconeurológicos (donde las posibilidades de éxito aumentan, ya que, una vez superados los problemas más psiconeurológicos, el niño será capaz de desarrollar todas sus posibilidades lingüísticas, pues esta función no estará comprometida).

También introducción a la enseñanza de la lectura (confección de un programa de exigencia de lectura en diferentes niveles). En cuanto a la reeducación articulatoria; los trastornos articulatorios dentro del síndrome de la dislexia son generalmente debidos a perturbaciones de naturaleza propioceptiva, es decir, causados por una representación deficiente del esquema corporal fono-articulatorio.

Las técnicas que permiten la corrección de los defectos articulatorios entran dentro de la metodología logopédica general. Se tienen que precisar las características propioceptógenas y audiógenas de las deficiencias articulatorias y proceder reforzando y modificando los patrones que se encuentran debilitados y distorsionados. Se enfatizará auditivamente la pronunciación correcta, sin exigir (de entrada) la realización por parte del niño; poco a poco, las asociaciones audiovisuales y propioceptivas se irán cumpliendo.

Mientras que la reeducación postural, el desarrollo postural normal permite una conexión del niño consigo mismo y con el mundo que le rodea. La experiencia que el niño haya adquirido antes de la comprensión y la ejecución del habla ha estado basada fundamentalmente, en la evolución postural y perceptual. Desde los 3 primeros meses, el niño va estableciendo un diálogo corporal con su medio,

sus reacciones de placer o de disgusto, se manifiestan por medio de cambios en sus posturas, actitudes y movimientos.

Cualquier retraso postural o motor, perturba la adquisición de las conexiones adecuadas con el medio y, como consecuencia, la adquisición del lenguaje. Gracias al conocimiento corporal, se llega al conocimiento del mundo exterior.

La ejercitación postural se realizará en los casos de falta de organización de la imagen corporal, principalmente, cuando el niño duerma adoptando patrones posturales confusos, cuando presente movimientos poco ágiles, cuando manifieste un retardo en la aparición del habla, dificultades en la articulación, o cuando existan distorsiones en la percepción.

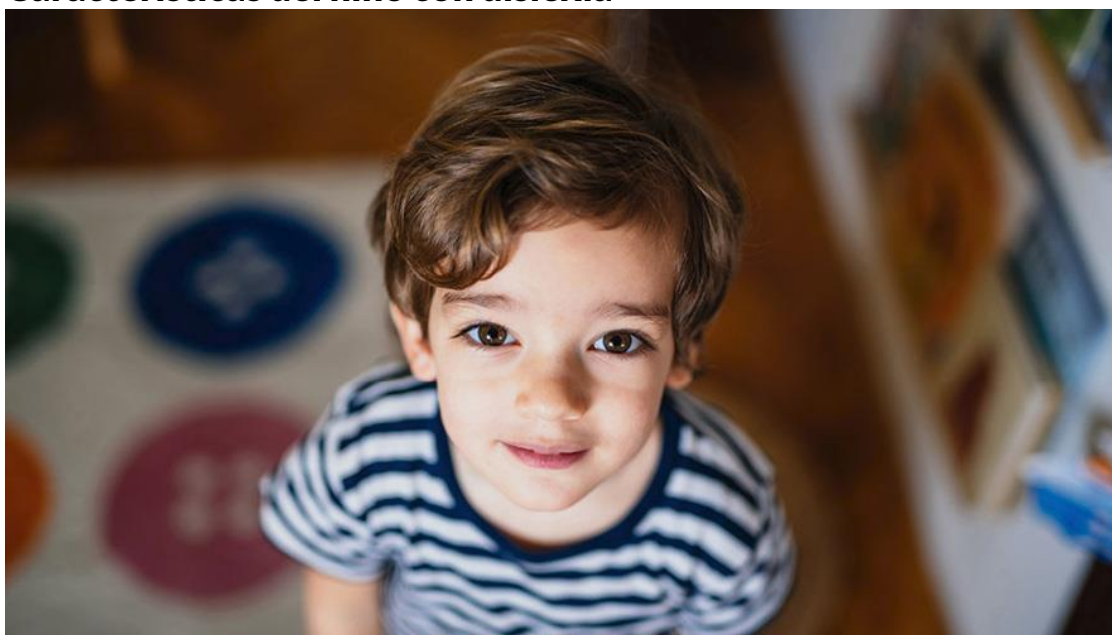


ANEXO

En el siguiente anexo encontrarás los ejercicios de ejercicios de reeducación sensorio-perceptual, ejercicios para la ejercitación auditiva y audio temporal Y ejercicios de ejercitación gnóstica y táctil

[Ejercicios de reeducación sensorio-perceptual](#)

Características del niño con dislexia



Según afirma Fernanda Fernández (1974), en cuanto a la dinámica general

- Falta de atención: debido al gran esfuerzo intelectual que han de realizar, presentan un alto grado de fatigabilidad.
- Desinterés por el estudio: debido a la falta de atención, unido a un medio familiar y escolar poco estimulante.
- Inadaptación personal: al no orientarse correctamente en el espacio y el tiempo, se encuentra sin puntos de referencia, presentando inseguridad e inestabilidad emocional.
- Sentimientos de inferioridad: consecuencia del bajo rendimiento.
- Sensación de fracaso que le lleva a ser inseguro e inhibido, o bien, todo lo contrario, desobediente y negativo.

En cuanto a la escuela:

De 4-6 años

- ✚ Retraso en el lenguaje oral: dislalias, omisiones, confusiones e inversiones de fonemas, inversiones de sílabas, pobreza de vocabulario y comprensión verbal baja.
- ✚ Retraso en la estructuración y conocimiento del esquema corporal.
- ✚ Dificultad en los ejercicios sensorio-perceptivos: colores, formas y tamaños.
- ✚ Torpeza motriz.

De 6-9 años

- ✚ Retraso en el lenguaje oral: inversiones y confusiones de fonemas, expresión verbal pobre, dificultad para adquirir nuevo vocabulario.
- ✚ Retraso en la lectura: confusiones y omisiones de letras, inversiones, reiteraciones, y omisiones de sílabas, omisiones de palabras, falta de ritmo, lentitud, respiración sincrónica, signos de puntuación no marcados, saltos de línea o repetición de esta, lectura mecánica.
- ✚ Problemas en la escritura y en el cálculo.

Mayores de 9 años

- ✚ Problemas en el lenguaje oral: por estructurar correctamente las frases, pobreza de expresión y de comprensión.
- ✚ Problemas en la lectura: continúan con la lectura no comprensiva, tienen dificultad para utilizar el diccionario.
- ✚ Los problemas se proyectan a las demás materias, debido a las dificultades en la orientación espacio temporal: historia, geografía, geometría.
- ✚ Problemas en la escritura y el cálculo mental.

Prevención



Para no tener que llegar a la intervención propiamente dicha de la lectoescritura, es necesario que los niños de preescolar sean observados para ver si ya existe alguna dificultad en este aprendizaje y poder incidir antes de que lleguen a primaria. Por esta razón, hay unas «pruebas predictivas», las más utilizadas en nuestro país son: ABC (Filho, 1937), Test de Inizan (1963), Test Reversal (García Manzano, 1977) y Badimale de Molina (1981).

Estas pruebas han sido muy criticadas, ya que el índice de correlación con el éxito de la lectura resulta similar al que se podría obtener con cualquier tipo de prueba que determine el CI (coeficiente intelectual). Según Peña-Casanova, su defecto básico es que se limitan a las únicas capacidades del niño y no nos informan sobre cuál es su comportamiento, cuál es su entorno y cuáles son las circunstancias que le rodean.

Se debería tener en cuenta qué niños son candidatos de tener, en el futuro, algún problema en el aprendizaje de la lectoescritura, es decir, los niños y niñas que estarán dentro del grupo de riesgo. Estos serán los que presenten las siguientes características:

01

Presentan dificultades en el habla o lenguaje.

Presentan conductas de inadaptación en las tareas de grupo (falta de atención, hiperactividad, pasividad).

02**03**

Presentan dificultades perceptivas observables en el dibujo o juegos sensoriales (clasificación).

Presentan retraso psicomotor, especialmente en la motricidad fina, observables en la forma en que cogen los objetos, los trabajos manuales, las actividades de psicomotricidad.

04

05 Si un maestro de educación infantil tiene algún niño con estas características, le tendría que prestar una atención especial, sin hacer que el niño se sienta diferente a los demás.

En cuanto a la escuela, Peña-Casanova cree que sería interesante realizar algunas modificaciones, con la finalidad de fomentar una flexibilidad en el aprendizaje y conseguir que este fuera más fácil para todos los alumnos. Estas modificaciones serían las siguientes:

- Reducir el número de alumnos por clase o incluir un profesional de refuerzo que pueda ayudar a los maestros, dedicando un tiempo especial a los niños que lo necesiten, pero dentro de la misma aula.
- Evitar un aprendizaje excesivamente precoz; se aconseja no comenzar el aprendizaje formal de la lectoescritura hasta Primaria, dedicando los cursos de preescolar a un desarrollo global de las capacidades de los niños.
- No imponer un ritmo preestablecido ni objetivos estrictos en el currículum del aprendizaje lector, para evitar acumular contenidos sobre unas bases inestables.
- Tendría que ser posible que en una misma clase existieran diferentes ritmos de aprendizaje.
- Evitar que la lectura sea un tema de sanciones o de competitividad entre los niños.
- Procurar que la aplicación del método que se utilice sea vivo, activo y, siempre que sea posible, lúdico.

Sindo Froufe (1989) cree que es muy importante la tarea de prevención, para que no se instaure el trastorno de la dislexia como tal; propone unas conductas predictivas y unos ejercicios concretos, que nos demuestran cuáles son, para él, las causas que provocan la dislexia. Las conductas son las siguientes:

Evitar el aprendizaje prematuro de la lectoescritura: Se tendría que tener en cuenta una serie de factores antes de empezar el aprendizaje de la lectura y la escritura: la edad cronológica (que por sí sola no es un criterio sólido para el inicio o no del aprendizaje, pero nunca se tendría que empezar antes de los 6 años); la edad mental (que, como mínimo, tendría que ser de 6 años o 6;6;) edad conductual, las habilidades motoras de desarrollo, la dominancia lateral, la atención, la percepción y el lenguaje oral del niño.

Cuidar el desarrollo evolutivo del lenguaje en el niño: según estudios, si este presenta dificultades en el lenguaje oral, es probable que presente también problemas en cuanto al aprendizaje de la lectura y la escritura.

Fomentar una buena enseñanza preescolar: el período preescolar es fundamental para el desarrollo posterior de la persona en todas sus dimensiones. Al acabar esta etapa, el niño tendría que: dominar su propio cuerpo, las relaciones espacio-temporales, la lateralidad, las percepciones

motrices, el ritmo, el equilibrio, la coordinación visomanual, el tono muscular y otros factores que ayuden a la maduración total del niño.



ANEXO

En el anexo podrá encontrar cuáles son los ejercicios prácticos que propone el autor entre los que se encuentran respiración y relajación, dominio del esquema corporal, coordinación visomotriz, entre otros.

[Ejercicios prácticos](#)

Ideas claves



- La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje en personas sin discapacidades intelectuales, enseñanza ni daño neurológico o enfermedad mental.
- Ha sido estudiada desde varios enfoques como el perceptivo-visual, psicolingüístico y de tipo genético y neuroanatómico. Además, existe la dislexia fonológica, superficial y mixta, en la que cada una se manifiesta con determinados síntomas.
- Precisar las características o síntomas de la dislexia, analizando el proceso que realiza la persona cuando lee o escribe, para poder establecer el diagnóstico y abordar los procedimientos de intervención.
- Es vital observar a los niños de preescolar para ver si existe dificultad de aprendizaje para la tarea de prevención.